

Dysnatrémie chez le cérébrolésé

$\text{Na}^+ > 145 \text{ mmol/L}$

Polyurie $> 400 \text{ mL/3 h}$
et densité urinaire < 1005 ?

oui

Diabète insipide central
(chirurgie hypophysaire, TC)
→ desmopressine $2 \mu\text{g IV}$
→ compenser la diurèse

non

Autres causes :
osmothérapie (SSH,
mannitol), apports
d'eau insuffisants

$\text{Na}^+ < 135 \text{ mmol/L}$

Osmolalité plasmatique basse
et natriurèse $> 30 \text{ mmol/L}$

Volémie et bilan sodé ?

hypovolémie

Perte de sel (CSW)
hypovolémie,
bilan sodé négatif
→ NaCl, $\pm$ fludrocortisone

euvolémie

SIADH
euvolémie
→ restriction hydrique
(jamais dans l'HSA)

Hyponatrémie symptomatique (convulsions, HTIC) : NaCl hypertonique en bolus. Hyponatrémie chronique : ne pas corriger de plus de $8\text{--}10 \text{ mmol/L}$ par 24 h (myélinolyse). Ionogramme sanguin et urinaire répétés.